

Inwentarz *zabezpieczeń*

Sprawdzanie, zapewnianie, unikanie, rytuały. Każde z nich dało Ci kiedyś ulgę — i teraz utrzymuje lęk.

CZAS: 30 min Po 2-3 sesjach psychoedukacji

ŹRÓDŁO: Salkovskis (1991); Helbig-Lang & Petermann (2010); Olatunji i in. (2011)

JAK UŻYWAĆ

Przejrzyj **cztery kategorie** zachowań zabezpieczających i zaznacz wszystkie, które stosujesz. Dla każdego zaznaczonego oszacuj częstotliwość. Na końcu wybierz **trzy** najczęstsze — to one trafią do planu redukcji.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Zachowania zabezpieczające (ang. *safety behaviors*, Salkovskis 1991) to każde działanie, które ma **zapobiec** obawianej katastrofie lub **upewnić się**, że jej nie ma. Paradoks: dają krótką ulgę → wzmacniają wiarę, że zagrożenie było realne → cykl trwa. Helbig-Lang & Petermann (2010, meta-analiza): redukcja zachowań zabezpieczających przynosi **silniejszy** efekt niż sama ekspozycja bez tej redukcji ($d = 0.83$ vs 0.52). To **obowiązkowy krok** w protokole CBT lęku zdrowotnego.

01 Cztery kategorie — zaznacz swoje

1 · SPRAWDZANIE CIAŁA

- ☐ macanie węzłów chłonnych
- ☐ mierzenie pulsu (palec / smartwatch)
- ☐ mierzenie ciśnienia $>1 \times$ /dzień
- ☐ badanie piersi codziennie
- ☐ oglądanie pieprzyków przed lustrem
- ☐ oglądanie języka, gardła
- ☐ ważenie się codziennie / wielokrotnie
- ☐ sprawdzanie stolca / moczu
- ☐ powolne wdechy „czy serce regularnie”

2 · INFORMACYJNE

- ☐ googlowanie objawów
- ☐ czytanie forów medycznych
- ☐ porównywanie z opisami pacjentów
- ☐ oglądanie filmów o chorobach
- ☐ czytanie ulotek leków „na zapas”
- ☐ statystyki śmiertelności online
- ☐ aplikacje do samodiagnozy
- ☐ AI / chatboty z pytaniami medycznymi
- ☐ subskrypcja serwisów medycznych

3 · SPOŁECZNE ZAPEWNIENIA

- ☐ pytanie partnera/-ki „czy źle wyglądam”
- ☐ telefony do rodzica „czy to coś”
- ☐ wysyłanie zdjęć znamion znajomym
- ☐ powtarzanie pytań do tej samej osoby
- ☐ pytania w pracy w trakcie dnia
- ☐ wizyty u kolejnych lekarzy
- ☐ drugie i trzecie opinie
- ☐ prywatne badania „dla świętego spokoju”
- ☐ wracanie z tym samym objawem co miesiąc

4 · UNIKANIE I RYTUAŁY

- ☐ omijanie szpitali / przychodni
- ☐ unikanie filmów / artykułów o chorobach
- ☐ nieczytanie ulotek leków
- ☐ unikanie sportu „bo serce”
- ☐ unikanie rozmów o czyjejs chorobie
- ☐ noszenie suplementów „w razie czego”
- ☐ rytuały „na zdrowie” (gesty, słowa)
- ☐ specjalne diety zapobiegawcze
- ☐ telefon zawsze pod ręką (wezwanie pomocy)

02 Trzy najczęstsze — co dokładnie robię i po co

Wybierz 3 najczęstsze zachowania z poprzedniej strony. Dla każdego wpisz: częstotliwość, jaką katastrofę *zapobiega*, jaką ulgę daje (krótko / długo). To podstawa planu redukcji.

#	ZACHOWANIE <i>konkretnie</i>	CZĘSTOŚĆ <i>×/dzień</i>	CO MA ZAPOBIEC? <i>obawiana katastrofa</i>	ULGA <i>min / godz.</i>
1				
2				
3				

03 Paradoks — dlaczego nie pomagają

1 · ATRYBUCJA BŁĘDNA

„Przeżyłem/-am, bo sprawdziłem/-am”. *Naprawdę*: przeżyłeś/-aś, bo niebezpieczeństwa nie było. Mózg zapisuje błędną przyczynowość.

2 · BRAK KOREKTY

Sprawdzasz → ulga → nie dochodzi do testu „co by było, gdybym *nie* sprawdził/-a”. Mózg nigdy się nie dowiaduje, że jest bezpieczny.

3 · SKUPIENIE

Sprawdzanie kieruje uwagę *na ciało*. Im więcej skanujesz, tym więcej znajdziesz „nieprawidłowości”.

Klucz: zachowania zabezpieczające *działają na krótko* i *szkodzą na długo*. To kluczowy paradoks lęku zdrowotnego. Redukcja zabezpieczeń = jedyna droga do trwałej zmiany. Helbig-Lang & Petermann (2010): pacjenci, którzy zachowali nawet *jedno* zabezpieczenie po terapii, mieli 3× wyższy wskaźnik nawrotu w 12 mies.